七、胆管癌

外科　胆系疾病3
00:00:35--00:16:43

1. 病因：胆管结石（1/3的胆管癌合并胆管结石）、硬化性胆管炎、溃疡性结肠炎、先天性胆管扩张症、胆管囊肿空肠吻合术后（胆管结石硬、U先扩吻合）

2.分类

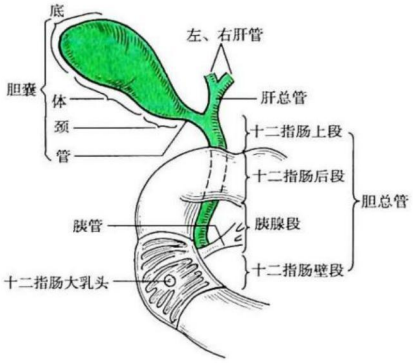
①下段胆管癌：十二指肠上缘至十二指肠乳头

②中段胆管癌：胆囊管开口至十二指肠上缘

③上段/肝门部胆管癌：左右肝管至胆囊管开口以上（上段多见 靠近肝血供好）

「理顺知识点」

- 血供越丰富，肿瘤越有生长优势
- 胆管癌越靠上越多见 Vs. 肝外胆管结石：好发于肝总管、胆总管下段（汇合部位）（越靠下越多见）



3.临床表现

①黄疸：出现早、进行性加重

②中下段胆管癌触及无痛、光滑、肿大的胆囊（courvoisier征）

而上段胆管癌胆囊无肿大甚至可缩小

③胆管癌生长缓慢，主要是淋巴转移、局部浸润、腹腔种植

④超声内镜判断胆管癌浸润深度、穿刺活检

「串联」

- 明明是恶性肿瘤，生长却十分缓慢
  - 皮肤的基底细胞癌
  - 卵巢的粒层细胞瘤

4.治疗

（1）根治性手术切除+清除肝十二指肠韧带内所有淋巴结（脉络化）

①下段胆管癌：胰头十二指肠切除术Whipple术、或联合切除肝（肿瘤累及肝）

②中段胆管癌：切肿瘤及距肿瘤边缘1cm的胆管（一旦中了）、作肝管-空肠RY吻合

「串联」

- 食管癌：切肿块及其上下缘≥5-8cm的组织
- 胃癌：一般5cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠1部的3-4cm
- 保乳乳腺癌切除术适合I、II期（切肿块+1-2cm组织）
- 直肠癌：一般来说Dixon术，切缘≥2cm，低位Dixon术，切缘≥1cm
- 结肠癌：肿瘤远端距切缘≥10cm

③上段/肝门部胆管癌：

Ⅰ肿瘤在肝总管	切胆囊+肝外胆管、作胆肠RY吻合
Ⅱ肿瘤侵犯左右肝管汇合部	
Ⅲ侵犯右肝管Ⅲa或左肝管Ⅲb （a的一竖在右边、b在左边）	切胆囊+肝外胆管+部分肝、作胆肠RY吻合
Ⅳ同时侵犯右、左肝管	多姑息治疗

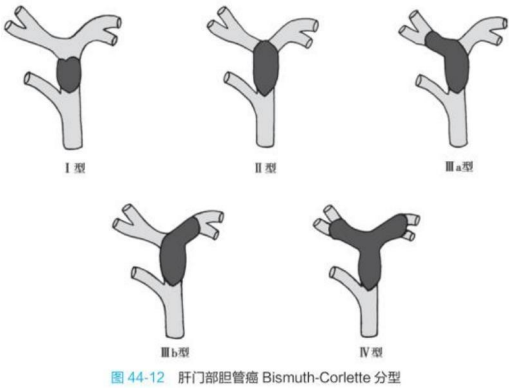


图 44-12　肝门部胆管癌 Bismuth-Corlette 分型

「理顺知识点」

- Ⅰ型上段胆管癌：切肿瘤所在的肝外胆管，作胆肠 RY 吻合，胆肠 RY 吻合时 Oddi 括约肌会被同步切除，没了 Oddi 括约肌就不需要胆囊了，因此同时切胆囊
- Ⅱ型上段胆管癌：部分切除范围同 Ⅰ 型，部分同 Ⅲ 型
- Ⅲ型上段胆管癌：离肝脏近，除了 Ⅰ 型的切除范围，还要多切部分肝脏

（2）姑息性治疗

①胆道引流术：PTCD、ENBD、放置内支架

若术中发现肿瘤不能切除作肝肠吻合或胆肠吻合内引流术

②胃空肠吻合术：肿瘤侵犯或压迫十二指肠造成消化道梗阻

（3）吉西他滨等化疗

八、胆管出血

外科　胆系疾病3
00:16:43--00:17:35

①肝内胆管出血多见

②原因：感染、创伤、肿瘤、血管性胆管出血，以胆管结石感染最常见（Charcot三联征+上消化道出血）

③治疗：多保守治疗。手术指征有反复发作大出血、合并严重胆管感染需手术引流者、引流术后发生胆管大出血者、原发疾病需要外科手术治疗者

九、胆管蛔虫

外科　胆系疾病3
00:17:35--00:19:29

①阵发性钻顶样绞痛，突发突止（间歇期可完全缓解无症状），剧烈腹痛与较轻腹部体征不相称

（虫子要休息）

②多无黄疸或轻度黄疸（多为不完全性梗阻）

③多保守治疗

「理顺知识点」

- 虫体活动时可引起钻顶样绞痛，间歇期则症状缓解
- 突发突止见于：胆道蛔虫、阵发性室上速
- 症征不符见于：十二指肠二三部损伤、肠系膜上动脉栓塞、胆道蛔虫症

十、胆管闭锁

外科　胆系疾病3
00:19:29--00:30:23

1.肝外胆管闭锁分型（胆肝门）

Ⅰ只涉及胆总管

Ⅱ肝管闭锁（实际上肝总管闭锁）

Ⅲ肝门部胆管闭锁（最常见）

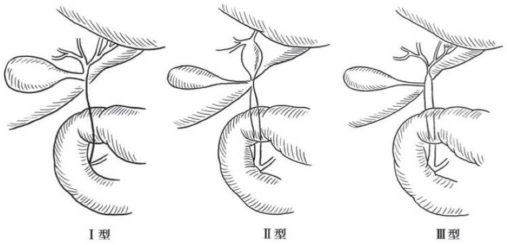


图 44-5　胆道闭锁

2.出生后1-2个月出现持续性黄疸、肝肿大、发育不良

3.苯巴比妥、激素治疗无效

「理顺知识点」

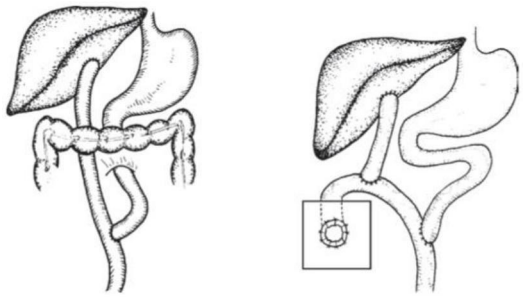
- 苯巴比妥：肝药酶诱导剂，能增强UDP-葡萄糖醛酸转移酶的活性，促进UCB转化为CB
- 新生儿溶血（母体内的Rh抗体进入胎儿引起）可导致溶血性黄疸（红细胞破坏↑→UCB↑→少部分未转化的UCB反流入血→血UCB↑），苯巴比妥促进UCB转化为CB→黄疸减轻
- 胆管闭锁导致梗阻性黄疸：苯巴比妥无法改善胆汁淤积，因此苯巴比妥治疗无效

4.尽量出生2个月内手术

①尚有部分肝外胆管通畅、胆囊大小正常→肝外胆管或胆囊与空肠行RY吻合

②肝门部胆管闭锁、但肝内仍有胆管腔→Kasai肝门-空肠RY吻合（闭锁-开塞露-肛门-肝门）

③肝移植的适应症：Kasai术后无效、肝内外胆管完全闭锁、已发生肝硬化


图 44-6　胆道闭锁 Kasai 手术示意图

十一、先天性胆管扩张症（旧称先天性胆总管囊肿）

外科　胆系疾病3
00:30:23--00:40:20

1.分型

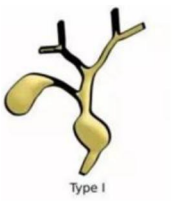
Ⅰ肝外胆管尤其胆总管囊性扩张、直径最大可达25cm（最常见）

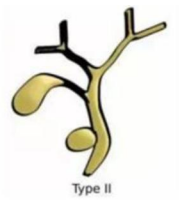
Ⅱ胆总管侧壁局限性扩张呈憩室样（2B有包）

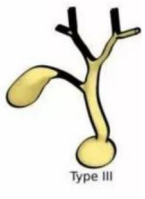
Ⅲ胆总管十二指肠壁内段呈囊状膨出（123）

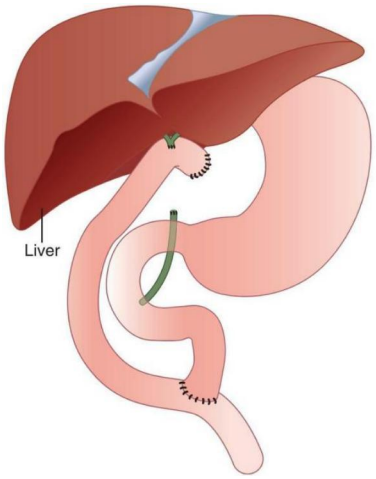
Ⅳ肝内、外胆管扩张（死）

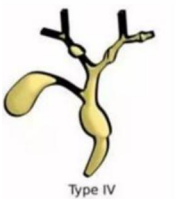
Ⅴ/Caroli病：肝内胆管多发扩张、伴肝纤维化；肝外胆管无扩张（燃烧我的卡路里-内）

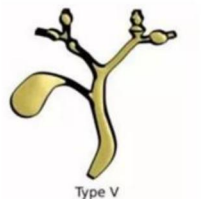












2.右上腹痛（多为钝痛/胀痛）、右上腹肿块（多为表面光滑的囊性肿块）、黄疸（呈间歇性蓄水池）

80%在儿童期发病，10%癌变率

「理顺知识点」

- 先天性胆管扩张症：当胆管形成囊性扩张时，会形成胆汁的“蓄水池”。胆汁在此处蓄积达到一定容量时，囊腔排空不畅，导致胆管内压力升高，引发黄疸；当蓄积的胆汁流出“蓄水池”，胆管内压力减轻，黄疸随之减轻→间歇性黄疸

3.尽早手术

①完全切除扩张的胆管+胆肠RY吻合，合并局限性肝内胆管扩张者需同时切除病变部分肝脏

②肝内胆管扩张病变累及全肝或已发生肝硬化需肝移植

「理顺知识点」

- 有 10% 癌变率→尽早手术
- 肝内胆管结石、先天性肝内胆管扩张的本质都是局限病变影响肝脏，导致病变部分肝脏异常，因此均需同时切除病变部分肝脏
- 肝脏广泛病变不适合切除，切除后易引起肝衰竭，只有区域性、局限性病变才适合肝切除（肝脏手术需关注术后肝功能）

专题串联

黄疸有没有&胆囊大不大

	黄疸	胆囊增大	其它	主要治疗
胆囊结石	× Mirizzi征√	× 胆囊梗阻、Mirizzi征√	阵发性胆绞痛（右上腹痛+不黄）	LC：有症状、无症状但有指征（结石≥2-3、息肉≥1、慢性胆囊炎、瓷性胆囊、糖尿病、心肺功能障碍）
急性胆囊炎	多 ×	√且痛 （Murphy征）	持续胆绞痛阵发加剧、发热、腹膜炎、胆囊壁＞4mm	≤3天急诊LC >3天急诊PTGD或胆囊造口，3个月后LC
胆囊癌	若不伴胆管梗阻×	可√	好发底、体部	手术
肝内胆管结石及炎症	多 ×	×	好发肝左外叶和右后叶，反复肝区胸背部闷胀痛	胆管切开取石或切除病变部分肝脏
肝外胆管结石及炎症	√且波动性	可大：胆总管堵石胆汁下不来 不大：胆总管结石很多时候是胆囊结石掉下来的 可缩小：慢性胆囊纤维化缩小	Charcot征（胆绞痛+黄疸+寒战高热） 甚至Reynolds征（Charcot征+休克+中枢抑制）	①结石≤3枚且＜1cm：经十二指肠内镜取石 ②胆总管切开取石（十二指肠上段）+T管引流 ③结石嵌顿在胆总管开口：内镜Oddi括约肌切开EST+取石+ENBD ④胆总管远端狭窄致梗阻无法解除：胆肠吻合+切胆囊 ⑤AOSC：急诊解除梗阻降低压力（PTCD、ENBD、或胆总管切开减压+T管引流）、同时抗休克（补平衡盐）
胆管癌	√且进行性	上段：×甚至缩小 中下段：√且无痛 （courvoisier征）	上段/肝门部多见	上段：切胆囊+肝外胆管（或+部分肝）+胆肠吻合 中段：切肿瘤+1cm胆管+肝管空肠吻合 下段：Whipple术或联合切除肝
胆管蛔虫	多 ×		阵发性钻顶样绞痛、突发突止、症征不符	保守为主
胆管闭锁	√且持续性		发育不良、苯巴比妥无效	尽量出生2个月内手术如Kasai等

先天性胆管扩张症	√且间歇性		钝/胀痛、光滑的囊性肿块	尽早完全切除扩张胆管+胆肠吻合等
胰头癌	√且出现晚、进行性	√且无痛（courvoisier征）	CT诊断和评估可切除性	Whipple术
壶腹癌	√且波动性（有减退）	√且无痛（courvoisier征）		Whipple术
十二指肠癌	√且出现晚、慢、浅	√且无痛（courvoisier征）		Whipple术

「理顺知识点」

- 胆石症并发症（多选题一般都全选）：胆道感染（胆囊/管炎）、肝脓肿、脓毒症、休克、穿孔（继发性腹膜炎、xx周围脓肿、瘘→胆石性肠梗阻）、胆道炎性狭窄、上消化道出血、癌变、胰腺炎、胆汁淤积性肝硬化（肝功能不全、门脉高压、肝衰竭）
- 诊断
  - 胆囊结石：结石位于胆囊内，不影响胆汁排泄→无黄疸
  - 胆囊梗阻→影响胆汁排泄→胆囊增大
  - Mirizzi综合征（胆囊管与肝总管伴行过长、或两者汇合位置过低，持续嵌顿在胆囊颈、管的结石压迫肝总管致其狭窄）：胆囊管、肝总管梗阻→影响胆汁排泄→黄疸、胆囊增大
  - 胆囊炎本身不影响胆汁排泄→多无黄疸
  - 若肝内胆管结石仅局限于某肝段、肝叶者，胆汁仍可通过其他未阻塞的胆管分支引流至肝总管，不会引起胆汁排泄障碍→多无黄疸
  - 胆管癌：肝外胆管内有肿瘤→堵塞胆管→胆汁排泄障碍→黄疸
  - 随恶性肿瘤发展，瘤体逐渐增大→梗阻逐渐加重→黄疸进行性加重
  - 上段胆管癌：位于胆囊管开口以上，不影响胆汁排泄，但阻止肝脏产生的胆汁流入胆囊→胆囊缩小（废用性萎缩）
  - 中下段胆管癌：都有胆汁排泄障碍→胆汁淤积→胆囊被动增大（Courvoisier 征：无痛、光滑、肿大的胆囊）
  - 胆道闭锁：新生儿出现→胆汁排泄障碍→持续性、进行性黄疸（苯巴比妥无效）
- 治疗
  - 胆囊结石切胆囊（有症状、无症状但有指征）
  - >3天的急性胆囊炎：胆囊被大网膜包裹，胆囊局部解剖结构不清→择期切胆囊
  - 胆管结石取石头
  - 外科行胆总管切开取石，通常从十二指肠上段作切口，切口位置比较高，但此时结石嵌顿在肝胰壶腹，离切口远，因此选择内镜下 Oddi 括约肌切开术，搭配ENBD引流
  - 胆总管远端因为炎症的狭窄导致梗阻无法解除→直接胆管−空肠 Roux−en−Y 吻合术，做了Roux−en−Y 吻合术都要同步切胆囊
  - 中段胆管癌：切肿瘤及距肿瘤边缘 1cm 的胆管→保证切缘阴性
  - Ⅰ 型上段胆管癌：切肿瘤所在的肝外胆管，作胆肠RY吻合，胆肠RY吻合时 Oddi 括约肌会被同步切除，没了 Oddi 括约肌就不需要胆囊了，因此同时切胆囊
  - Ⅲ 型上段胆管癌：离肝脏近，除了 I 型的切除范围，还要多切部分肝脏

英文小结：

AOSC急性梗阻性化脓性胆管炎

LC腹腔镜胆囊切除术

PTGD经皮经肝胆囊穿刺引流

PTCD经皮经肝胆管穿刺引流（PTC经皮经肝胆管穿刺造影）

MRCP磁共振胰胆管成像（水成像）

ERCP经内镜逆行性胰胆管造影

治疗性ERCP：内镜下Oddi括约肌切开EST+取石+鼻胆管引流ENBD

Whipple术：胰头十二指肠切除术

courvoisier征：深吸气触及无痛/光滑/肿大的胆囊——中下段胆管癌、胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌

「理顺知识点」

- 需要做胆肠R-Y吻合+同时切胆囊
  - 肝外胆管结石及其炎症伴有
    - 胆总管远端炎症狭窄致梗阻无法解除、胆总管扩张
    - 胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管
    - 胆管因病变部分切除、无法再吻合
  - 某些肝内胆管结石
  - 胆管癌
  - 胆管闭锁（III型：Kasai肝门-空肠RY吻合）
  - 先天性胆管扩张
  - 胆管损伤
  - 姑息性减黄（不能切除的胆管癌、胆囊癌、胰腺癌…）

真题解析·胆系疾病

外科　胆系疾病3
01:15:50--02:12:30

1.2013N86A以下胆囊疾病中，与胆囊癌发病无关的是

A.胆囊结石＞2cm

B.“瓷化”胆囊

C.胆囊腺瘤

D.胆囊胆固醇息肉

　答案：1 D

2.2013N116-117A女性，82岁，上腹痛，尿黄1周，1天来寒战、高热。有高血压、糖尿病病史，药物控制，半年前心肌梗死。查体：T39.5℃,P120次/分，BP96/82mmHg，神志淡漠，皮肤、巩膜黄染，右上腹部压痛，Hb115g/L，WBC22×10^9/L。B超提示肝内外胆管扩张，胆囊增大，胆总管远端显示不清。

116.此病状最符合

A.Charcot三联征

B.Reynolds五联征

C.Whipple三联征

D.Grey-Turner征

117.以下治疗方法中，不宜采取的是

A.ENBD

B.PTCD

C.急诊探查胆总管并引流

D.先保守治疗，待休克纠正后手术

3.2013N177X以下关于胆囊结石病人应行胆囊切除手术的适应征有

A.年轻人无症状

B.胆囊结石＞2cm

C.常发作右上腹痛

D.胆囊结石合并糖尿病

4.2014N81A男性，56岁。1年前因胆管癌行肿瘤切除、胆肠吻合术，半年来反复发热，服抗生素有效，考虑可能有胆道感染。为明确诊断应

A.肝胆B超　　胆肠吻合术后、气体干扰

B.MRCP

C.上腹CT　　在胆系疾病连B超都比不上

D.发热时查肝功能

5.2014N111-113A女性，80岁。3天来发现巩膜黄染、皮肤瘙痒，来院就诊。

111.为了解黄疸性质，以下检查项目中最有意义的是

A.乙肝病毒标志物

B.转氨酶水平

C.DBil/TBil

D.AFP

　　答案：2-5 BD BCD B CAA

112.为了解胆道是否有梗阻及梗阻部位，最简便的检查方法

A.B型超声

B.CT

C.MRI

D.ERCP

113.3天后患者突然高热，体温达39℃,WBC15.0×10^9/L，此时最佳处理方案为

A.PTCD

B.MRCP

C.加大抗生素用量

D.急诊手术引流

6.2015N87A男性，60岁。黄疸、尿色变深、皮肤瘙痒两周。查体：T36.5℃,皮肤巩膜黄染。右上腹无痛性圆形肿块，随呼吸上下活动。其肿块最可能是

A.胆囊

B.肝脏下缘

C.胰头部肿瘤

D.胆总管囊肿

7.2015N111−113A女性，42岁。肝外胆管结石病史3年，10小时前突然右上腹绞痛，恶心、呕吐，继而出现寒战、高热、嗜睡、神志淡漠。查体：T40℃,P120次/分，BP85/60mmHg，上腹轻压痛。

111.该患者最可能的诊断是

A.肝脓肿

B.急性胆囊炎

C.急性胰腺炎

D.急性梗阻性化脓性胆管炎

112.首选的腹部检查为

A.增强CT

B.B超

C.MRI

D.X线片

　答案：6−7 A DBD

113.对该患者最佳的处理方法是

A.静脉大量补液

B.静脉应用升压药

C.联合应用抗生素保守治疗

D.紧急手术　胆总管切开减压+T管引流 要同时抗休克

8.2015N178X以下选项中，属于Calot三角边线的有

A.肝脏下缘

B.肝总管

C.胆总管

D.胆囊管

9.2016N77A女性，45岁，B超示多个胆囊结石，最大的直径为1.2cm，胆囊壁光滑、不厚，无明显症状，患者要求保留胆囊，应采取的措施是

A.继续观察

B.保胆取石

C.体外碎石

D.药物碎石

10.2016N87A以下无症状的胆囊疾病中，应尽早手术的是

A.胆囊多发息肉样病变

B.胆囊单发息肉样病变1.2cm

C.胆囊多发结石　不看数量看大小

D.胆囊单发结石1.5cm

11.2016N113-115A女性，35岁，9个月前因先天性胆总管囊肿行囊肿切除、胆肠Roux-Y吻合术，术中曾输血400ml。2月来易“感冒”，自服抗生素好转，近1周来发热、寒战，最高体温达39℃。查体：P123次/分，BP102/80mmHg，R22次/分，巩膜黄染，双肺呼吸音粗，上腹轻压痛。化验：WBC18×10^9/L，中性粒细胞89%，TBil121μmol/L，DBil86μmol/L，ALT203U/L。

113.该患者最可能的诊断是

A.急性胰腺炎

B.急性肝炎

C.急性重症胆管炎

D.上消化道穿孔

　答案：8-11 ABD A B CDB

114.以下治疗方法中，最有效的是

A.加大抗生素用量

B.ERCP置管引流

C.腹腔镜探查

D.PTCD

115.引起该病症的根本原因最可能为

A.体质虚弱易感染

B.胆肠吻合口狭窄

C.肝门部胆管癌

D.术中输血感染肝炎

12.2016N116-117A女性，63岁。半年来因下肢骨关节病疼痛服用布洛芬治疗。10天来上腹不适，1周前突发腹痛，经禁食、输液4天后好转，但仍觉上腹胀满，不能进食，发热。查体：T37.8℃,P96次/分，BP130/80mmHg，上腹饱满有压痛，轻度肌紧张，肠鸣音正常。B超示胆囊6.8×3.5cm，壁厚3mm，胰腺显示不清，上腹肝下有一直径10cm含液性病变。实验室检查：WBC14×10^9/L，中性粒细胞84%，Hb112g/L，血尿淀粉酶正常。

116.该患者最可能的诊断是

A.胆囊穿孔后包裹积液

B.胃穿孔后包裹积液　顺着右结肠旁沟流下来，被肝周围负压吸引

C.胰腺假性囊肿　　血淀粉酶正常不优先考虑胰腺炎

D.巨大肝囊肿　　有点胀痛无其他感觉、液性病变不在肝内

117.当前最适宜的处理措施是

A.穿刺置管引流　　减轻症状、穿刺液可送检

B.继续保守治疗　　对应胰腺假性囊肿

C.胆囊切除术　　对应胆囊穿孔后包裹积液

D.开腹探查　　不要动不动就开腹

13.2016N175X急性非结石性胆囊炎的特点有

A.好发于老年女性

B.病情发展迅速

C.坏疽发生率高

D.长期肠外营养者易发生

　答案：12-13 BA BCD

14.2017N63A男性，65岁。反复上腹部不适、轻度黄疸3个月，腹痛，黄疸加重伴高热2天。入院查体：T39.5℃,P125次/分，BP75/50mmHg，右上腹压痛。腹部超声检查发现胆囊多发结石，胆总管直径1.5cm，胰头显示不清。血WBC15×10^9/L，中性粒细胞90%。该患者首选的治疗措施是

A.大剂量抗生素抗感染后择期手术

B.全胃肠外营养后择期手术

C.大量输液抗休克同时尽早手术

D.应用血管收缩剂至血压正常后及早手术

15.2018N62A男性，65岁，患胆总管结石。手术切开胆总管探查取石，并放置T管引流，术后T管造影发现仍有0.5cm残余结石，可经T管窦道取出残余结石的最短时间是

A.术后2周

B.术后4周

C.术后6周

D.术后8周

16.2018N100-102A女性，55岁，1月前因急性胆管炎、胆囊炎、胆总管结石急诊行胆囊切除、胆总管切开取石、T管引流术。

100.一般拔除T管的时间是

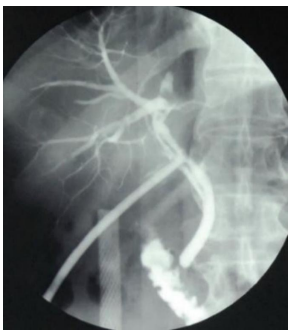
A.术后2周

B.术后4周

C.术后6周

D.术后8周

101.拔除T管前经T管胆道造影，结果如下图。此图显示的征像是



A.正常胆道造影

B.胆总管残余结石

C.壶腹部狭窄

D.左肝管显影不良

102.根据上述造影结果，下一步的处理应是

A.经T管窦道胆管镜取石

B.常规拔除T管

C.行Whipple手术

D.肝脏CT检查　MRCP更好

　答案：14-16　C B BDD

17.2018N160X肝内胆管结石可发生的并发症有

A.胆管癌

B.肝衰竭

C.胆管炎

D.门脉高压症

18.2019N62A女性，28岁，体检发现胆囊多发结石，最大直径0.6cm，无症状。应采取的处理措施是

A.胆囊切开取石术

B.胆囊切除术

C.服用药物排石

D.随访观察

19.2019N98-99A女性，55岁。反复发作上腹痛并发热8年，近日再次发作。查体：T39℃,P112次/分，BP132/86mmHg，巩膜不黄，上腹压痛，轻度肌紧张，肝区叩痛。化验：Hb132g/L，WBC13.8×10^9/L，N86%，ALT86U/L，TBil28.5μmol/L。MRCP示：左侧肝内胆管局限性扩张，其内可见多发低信号影，右侧肝内胆管及肝外胆管未见扩张，胆囊不大，肝左叶体积缩小。

98.该患者的诊断是

A.左肝脓肿

B.左肝癌

C.左肝内胆管结石、胆管炎

D.胆囊炎

99.对该患者最佳的治疗方案是

A.内镜下Oddi括约肌切开术

B.PTCD治疗

C.急行胆囊切除术

D.保守治疗后左半肝切除术

20.2019N163X胆囊结石可能发生的并发症有

A.梗阻性黄疸

B.肠梗阻

C.胆囊癌

D.胰腺炎

　答案：17-20 ABCD D CD ABCD

21.2020N61A正常成人每日胆汁分泌量为

A.200−600ml

B.800−1200ml

C.1300−1700ml

D.1800−2200ml

胆囊每天接纳的胆汁:500
肝脏每天分泌的胆汁 :800−1200
T管引流的胆汁200−300

22.2020N62A女性，45岁。B超发现胆囊多发息肉样病变，最大直径为0.6cm，无症状。对该患者的正确处理是

A.胆囊切除术

B.保留胆囊，息肉摘除术

C.观察，定期复查

D.熊去氧胆酸溶解息肉

23.2020N93−94A女性，43岁。1年来经常右上腹胀痛，有时出现黄疸、发热。外院发现胆总管扩张并有结石，行胆囊切除、胆总管探查术，取出结石一枚。术后3周经T管造影，结果显示：胆总管扩张，直径约5cm，腔内未见明显结石，肝内胆管未见扩张，十二指肠显影正常，胰管显影。

93.此结果提示

A.胆总管残余结石

B.胆总管下段肿瘤

C.先天性胆管扩张症

D.正常胆道影像

94.以下进一步的治疗措施中，首选的是

A.胆道镜取石

B.拔除T管，继续观察

C.Whipple手术

D.肝外胆管切除、胆肠吻合术

24.2020N134−135B

A.Horner综合征

B.Mirizzi综合征

C.Peutz−Jeghers综合征

D.Budd−Chiari综合征

一侧上睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷等表现属于

胆囊管结石压迫肝总管并致其狭窄时，称为

　答案：21−24 B C CD AB

25.2021N63A男性，65岁。上腹不适，食欲不振2个月，体重下降。近20天皮肤、巩膜黄染并进行性加重。粪便色灰白，尿色黄。查体：肝脾未触及，深呼吸时，于右肋缘下触及半球形肿物，墨菲征(−)。化验：TBil230umol/L，DBil186umol/L。最可能的诊断是

A.慢性肝炎

B.胆总管结石

C.胰头癌

D.肝癌

26.2021N96−97A女性，42岁。因持续上腹痛伴恶心、呕吐3天入院。2年前检查有胆囊结石，平时常有进油腻食物后上腹部不适症状。查体：T37.8℃,P100次/分，R24次/分，BP126/84mmHg，皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱。B超示胆囊内泥沙样结石。胆总管宽9mm，上段无结石，下段观察不清，胰腺肿大、增厚，周围有积液。化验：WBC13.0×10^9/L，血淀粉酶400U/dl（正常值40−180U/dl）。

血淀粉酶高优先考虑胰腺炎

96.最可能的诊断是

A.急性胃炎

B.急性胰腺炎

C.急性胆囊炎

D.急性胆管炎

97.目前最佳的治疗方案是

A.急诊手术引流

B.禁食、补液，应用抗生素

C.腹腔灌洗

D.经内镜Oddi括约肌切开

27.2021N160X胆道疾病的常见并发症有

A.癌变

B.狭窄

C.出血

D.肝脓肿

　答案：25−27 C BB ABCD

28.2022N93−94A男，45岁。突发右上腹痛伴寒战、高热1天入院。既往有“胃痛”病史。查体：T39.2℃,BP100/60mmHg，皮肤巩膜轻度黄染，心率110次/分，Murphy征(−)。B超：胆囊8×4cm，壁厚0.2cm，腔内未见结石，胆总管上段直径1.2cm，下段显示不清，血WBC15×10^9/L，血淀粉酶234U/L，TBil68μmol/L，DBil45μmol/L。

93.该患者最可能的诊断是

A.急性胆囊炎

B.急性胰腺炎

C.急性胆管炎

D.急性胃炎

94.为进一步明确诊断，最简单准确的检查方法是

A.腹部X线片

B.MRCP

C.ERCP

D.PTC

29.2022N134−135B

A.胰头癌

B.慢性胰腺炎

C.硬化性胆管炎

D.胆总管结石

黄疸进行性加重，一般无腹痛，最可能的诊断是

黄疸程度波动，常伴腹痛，最可能的诊断是

30.2023N64A男性，90岁。右上腹痛5天就诊。既往有心肌梗死、脑出血病史。查体：T38度，右上腹压痛明显。腹部B超提示胆囊10cm×5cm，壁厚0.5cm，腔内可见多发结石，直径最大1.5cm，胆总管直径0.6cm，化验血WBC15×10^9/L。最适宜的治疗方案是

A.急诊胆囊切除术

B.急诊胆囊切除加胆总管引流术

C.急诊经皮经肝胆囊穿刺引流术　PTGD

D.急诊开腹胆囊造瘘术

　　答案：28−30 CB AD C

31.2023N93−95A男性，76岁。腹痛、发热伴寒战10小时来诊。既往有心肌梗死、高血压病史，曾疑有胆总管结石。查体：T38.6度，P100次/分，BP90/60mmHg。巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常。化验：血WBC17.5 × 10^9/L。

93.最可能的诊断是

A.急性胆囊炎

B.急性胃肠炎

C.急性胰腺炎

D.急性胆管炎

94.为明确诊断，首选的检查是

A.ERCP

B.腹平片

C.MRCP

D.PTC

95.最合适的治疗措施是

A.采用非手术治疗

B.胆囊切除术

C.经内镜鼻胆管引流术

D.胆总管切开取石术

32.2023N100−102A女性，24岁。因间断上腹痛3个月就诊。查体：右上腹略饱满。化验：肝功能正常B超提示胆总管扩张，直径5cm左右，肝内胆管未见扩张。拟诊先天性胆管扩张症。

100.为明确诊断，进一步的检查是

A.超声内镜

B.ERCP

C.MRCP

D.PTC

101.检查显示胆总管全程呈囊状扩张，其分型是

A.Ⅰ型

B.Ⅱ型

C.Ⅲ型

D.Ⅳ型

　答案：31−32 DCC CAB

102.最适宜的治疗方法是

A.囊肿-十二指肠吻合术

B.囊肿切除，胆肠Roux-en-Y吻合术

C.囊肿-空肠吻合术

D.囊肿切除，肝管-十二指肠吻合术

33.2023N160X胆囊结石行胆囊切除术的手术指征，正确的有

A.结石直径≥3cm，无症状

B.儿童胆囊结石，无症状

C.伴有胆囊息肉样病变，直径大于1cm

D.瓷性胆囊

34.2024N98-99A男性，78岁。右上腹疼痛伴发热、恶心、呕吐5天入院。既往有高血压病10年，肺心病3年。查体：T38.5度，P102次/分，R24次/分，BP156/98mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹明显压痛，轻度肌紧张，肠鸣音弱。化验：血Hb125g/L，WBC18.6 × 10^9/L，血清淀粉酶286U/L。B超：胆囊12cm × 6cm，壁厚0.6cm，腔内可见直径3cm结石一枚，总胆管直径0.8cm，肝下可见积液，胰腺显示不清。

98.最可能的诊断是

A.急性胰腺炎

B.急性胆囊炎

C.急性胆管炎

D.十二指肠溃疡穿孔

99.首选的治疗方法是

A.PTCD

B.急诊开腹手术

C.PTGD

D.保守治疗

35.2024N134-135B

A.急性胆囊炎

B.急性化脓性胆管炎

C.重症急性胰腺炎

D.急性化脓性阑尾炎

Charcot三联征出现在

Cullen征出现在

　答案：33-35 ACD BC BC

36.2024N163X胆道出血的原因有

A.肝脏损伤

B.胆囊炎

C.胆管结石

D.肝脏肿瘤

37.2025N98-99A女性，55岁。1天前突发右上腹疼痛，伴恶心呕吐。2小时前寒战、发热来诊。既往胆囊结石病史10年。查体：T39.5℃,P100次/分，R18次/分，BP80/40mmHg。巩膜黄染。右上腹压痛，肝区叩击痛。化验：血WBC18×10^{9}/L。

98.最可能的诊断是

A.细菌性肝脓肿

B.上消化道穿孔

C.重症急性胰腺炎

D.急性梗阻性化脓性胆管炎

99.对明确诊断最有价值的检查是

A.腹部B超

B.MRCP

C.腹部CT

D.PTC

38.2025N132-133B

A.转移性腹痛、上腹痛减轻或消失

B.右下腹部疼痛、向会阴部放射

C.转移性腹痛、上腹痛持续

D.右上腹部疼痛、向右肩背部放射

急性胆囊炎的腹痛特点是

十二指肠溃疡穿孔的腹痛特点是

39.2025N161X肝内胆管结石行病变肝切除术的适应证有

A.区域性肝内胆管结石伴肝脏萎缩

B.弥漫性肝内胆管结石

C.难以取净的肝段结石伴胆管扩张

D.局限性肝内胆管结石伴胆道出血

　答案：36-39 ABCD D B/C DC ACD